

Neoplasias Benignas de la Piel

Guía de Estudio Detallada y Atlas Clínico

- Queratosis Seborreica
- Queratosis Actínica
- Dermatofibroma

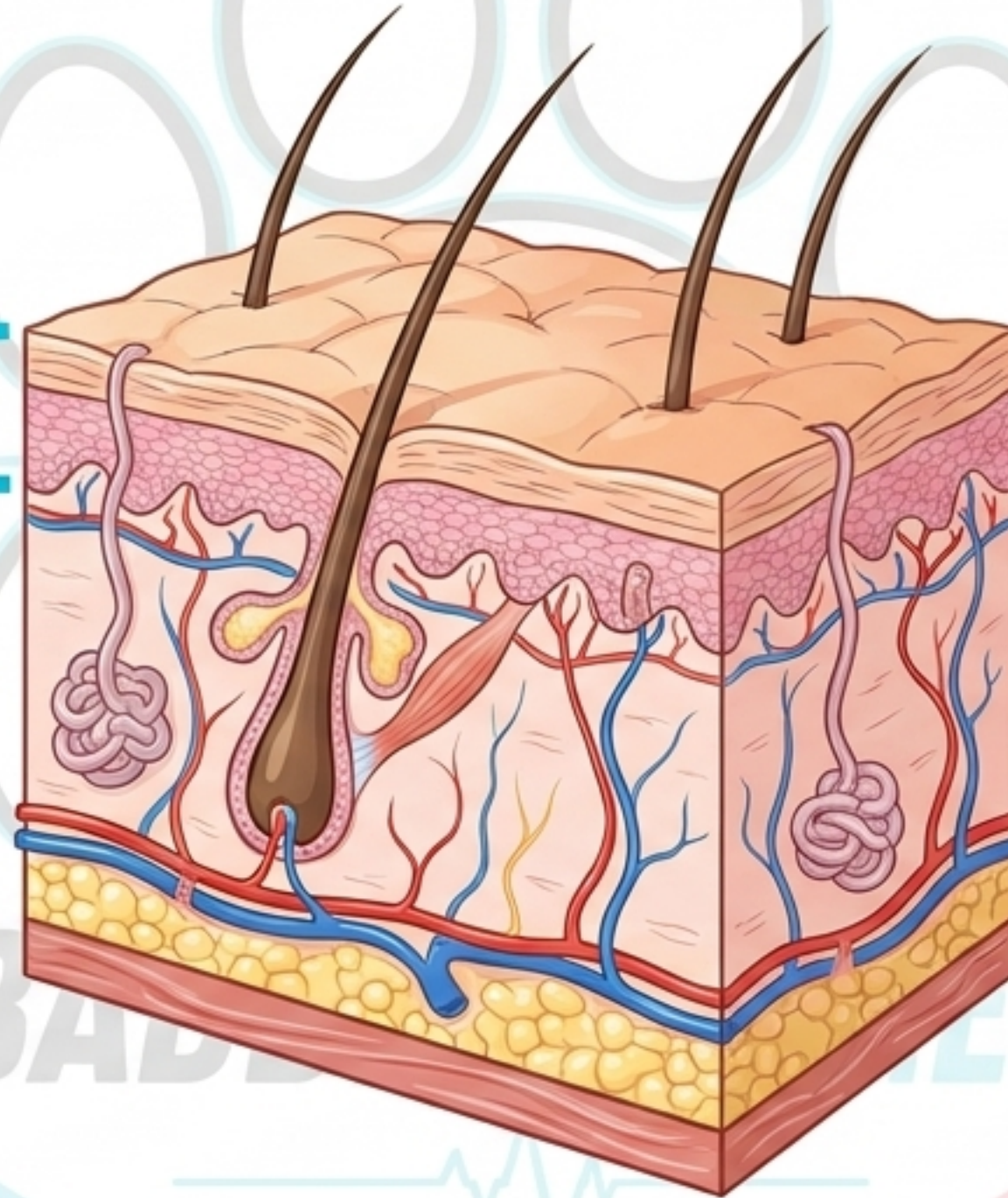


Clasificación Topográfica de las Neoplasias

EPIDERMIS

Queratosis Seborreica:
Neoplasia epidérmica
benigna madura.

Queratosis Actínica:
Neoplasia
intraepidérmica
inducida por UV
(Carcinoma
epidermoide in situ).



DERMIS

Dermatofibroma:
Tumor fibroso benigno
(Histiocitoma).



Queratosis Seborreica (QS): Definición y Etiología

Concepto

Neoplasia benigna de la epidermis. Muy frecuente en adultos de edad madura/avanzada.

Topografía

Predominio en cara y tórax. Ausente en palmas y plantas.

Clínica Clave

Neoformación pigmentada, bordes bien limitados. Superficie cubierta por una escama grasosa que se desprende al rascado.

Etiología y Genética

Exposición solar, factores genéticos. Alteraciones en genes supresores de tumores, marcadores de apoptosis (P33, BCL2) y mutaciones en FGFR3/PIK3CA.



Variantes Clínicas de la Queratosis Seborreica



Dermatosis Papulosa Nigra

Predominante en fototipos oscuros (Tipo IV). Múltiples lesiones agrupadas en región periorbitaria, mejillas y zona frontal.



Melanoacantoma

Presentación en tronco y cuello. Caracterizada por una pigmentación intensa y oscura.



Estucoqueratosis

Localización en miembros inferiores (piernas). Morfología digitiforme, superficie rugosa, color amarillento-anaranjado.



QS: Histopatología y Signo de Alerta

Hiperqueratosis
(capa córnea gruesa)

Papilomatosis



Acanthosis

**Sello Distintivo: Quistes Córneos
(o pseudoquistes)**

ALERTA ROJA: Signo de Leser-Trélat

Definición: Aparición repentina y eruptiva de múltiples QS, acompañadas de prurito intenso.

Asociación: Marcador de neoplasias malignas internas (Adenocarcinoma gástrico, linfomas, cáncer de mama, carcinoma espinoceleular de pulmón).



QS: Diagnóstico Diferencial y Algoritmo de Manejo

Diagnóstico Diferencial:

- Acrocordón (formas pediculadas)
- Nevus
- Verruga vulgar
- Carcinoma basocelular pigmentado
- Melanoma

Puede coexistir con Cuerno cutáneo o Enfermedad de Bowen.

Paso 1: Confirmación diagnóstica
(Dermatoscopia si hay duda).

NO

¿Es maligna?

Paso 2: ¿Produce síntomas
(prurito, inflamación) o hay
deseo estético?

Si

SÍ

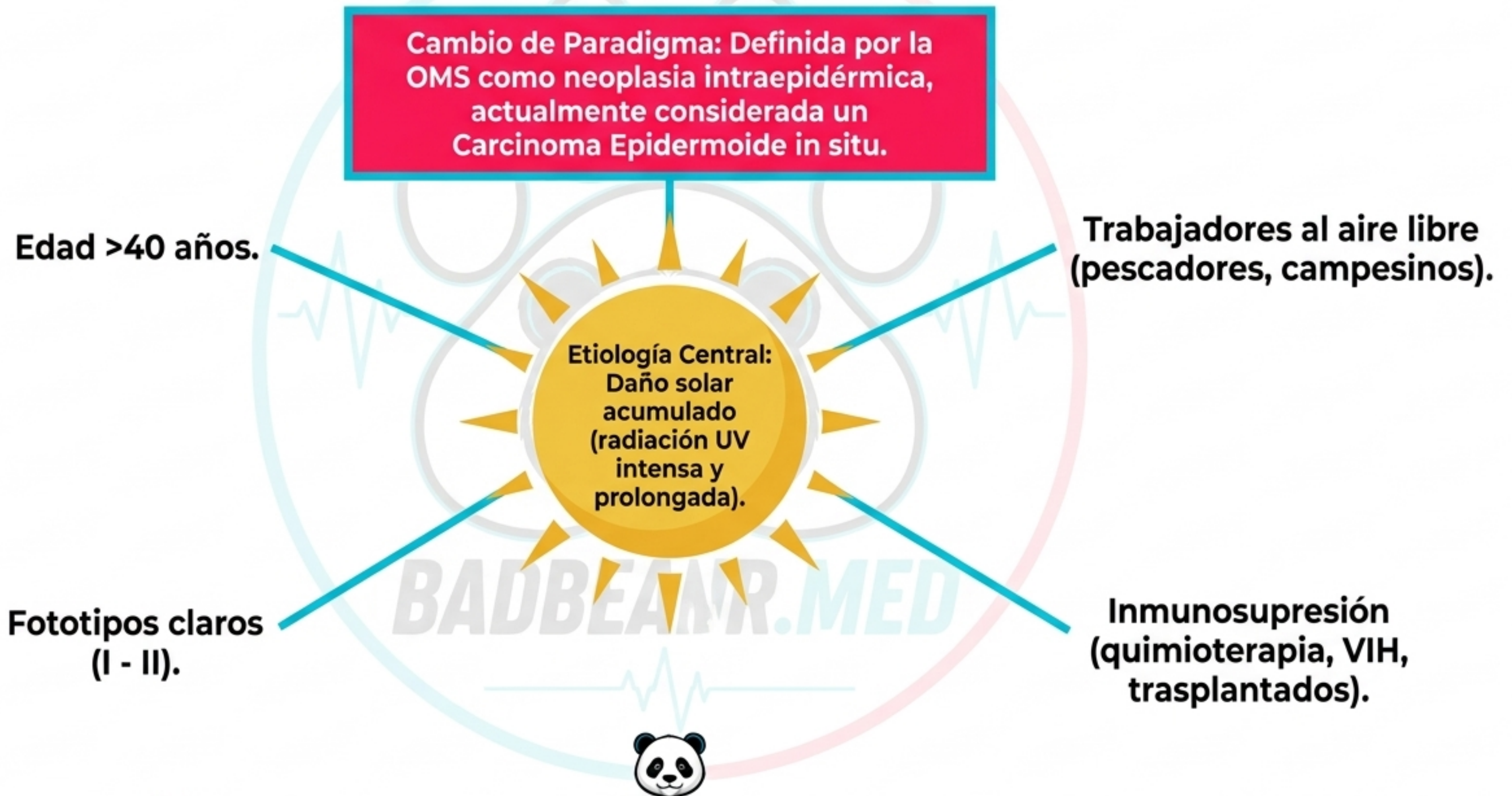
Si NO

Observación.

Tratamiento de elección:
Crioterapia (nitrógeno líquido) o
Electrodesección + Curetaje
(bajo anestesia local).



Queratosis Actínica (QA): El Carcinoma In Situ



QA: Evolución Clínica en 3 Grados



Grado 1 (Leve)

Ligeramente palpable
("sensación de aspereza").
**Mácula o pápula
eritematosa** con escama
fina.



Grado 2 (Moderado)

Costra gruesa y compacta.
Dermatoscopía: "**Patrón en
fresa**" (eritema con orificios
foliculares evidentes).

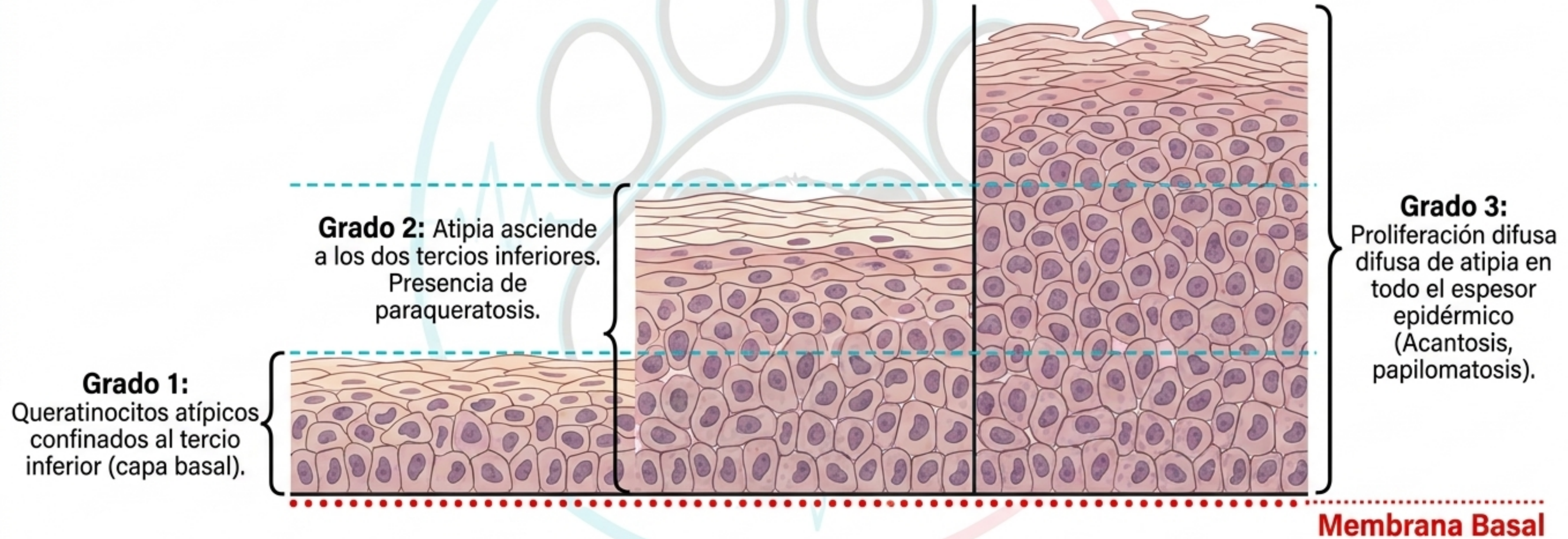


Grado 3 (Severo)

Costra **hiperqueratósica**
grosera, muy gruesa y
amarillenta.
Patrón dermatoscópico
irregular blanco-amarillento.



QA: Progresión Histopatológica



EL PUNTO CRÍTICO: Si los queratinocitos atípicos atraviesan la membrana basal, deja de ser QA y se convierte en un **Carcinoma Espinocelular Invasivo**.



QA: Diagnóstico Diferencial Crítico

Entidades Benignas / Inflamatorias

- Queratosis Seborreica
- Psoriasis (placas escamosas)
- Lupus Eritematoso Discoide (depresión central y ulceración)



Entidades Malignas / Premalignas

- Léntigo Solar / Léntigo Maligno Melanoma (cambio progresivo de bordes)
- Carcinoma Basocelular Superficial
- Carcinoma Epidermoide Invasivo Cutáneo



QA: Algoritmo de Tratamiento (Lesiones vs. Campo)

Queratosis Actínica

Vía A: Lesiones Aisladas (Pocas lesiones)

Objetivo: Destrucción física directa.

- Crioterapia (nitrógeno líquido)
- Electrocirugía
- Curetaje

Vía B: Terapia de Campo (Múltiples lesiones/Campo de cancerización)

Citotóxicos: 5-Fluorouracilo (5%) + Ác. Salicílico (10%).

Inmunomoduladores: Imiquimod (5% o 3.75%).
Estimula respuesta inmune.

AINEs Tópicos: Diclofenaco 3% en gel hialurónico
(Inhibidor COX-2).

Mecanismo Dual: Ingenol Mebutato (Citotoxicidad
directa + inmunidad).

Fototerapia: Terapia Fotodinámica (Ácido
metilaminolevulínico + luz).



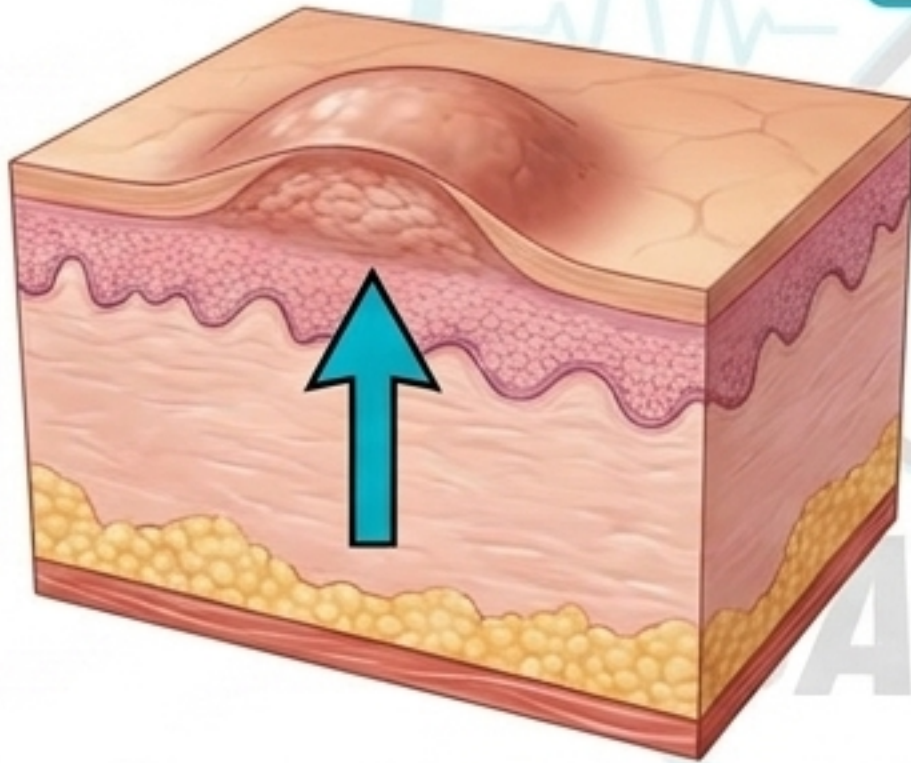
Dermatofibroma (DF): Definición y Clínica

Definición: Tumor fibroso benigno (Histiocitoma fibroso benigno / Angioma esclerosante).

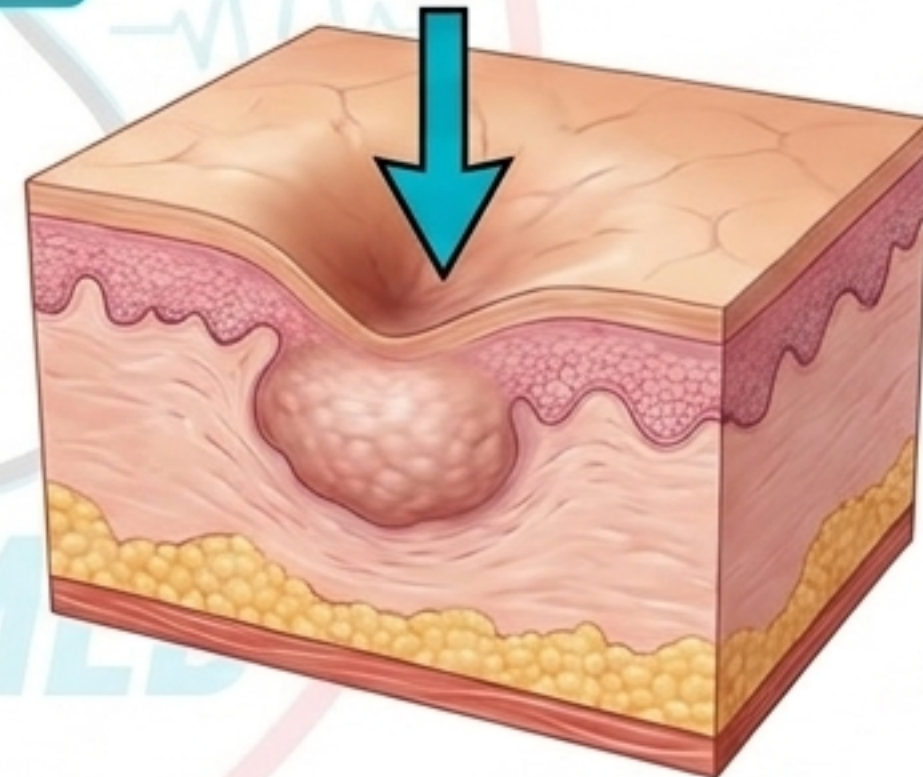
Etiología: Frecuentemente secundario a traumatismos menores (ej. picaduras de insectos).

Epidemiología: Predominio en mujeres, edad promedio ~30 años. **Topografía clásica:** Miembros inferiores (piernas, muslos).

Presentación Dual



Pápula: Sobreelevada, 2mm a 15mm, color pardo-rojizo o violáceo.



Nódulo: Deprimido hacia la dermis, consistencia firme ("como un borrador").



DF: El Signo del Hoyuelo e Histopatología



La Clínica Clave (Signo del Hoyuelo / Dimple Sign):

Al presionar lateralmente los bordes de la lesión con el pulgar y el índice, la lesión presenta un hundimiento central hacia la dermis.



Epidermis con hiperqueratosis superficial.

Dermis: Gran cantidad de tejido fibroso denso. Proliferación desordenada de fibroblastos y miofibroblastos en conglomerados.

Bordes no bien circunscritos, se extienden a tejidos adyacentes.



DF: Diagnóstico Diferencial y Manejo

Diagnóstico Diferencial

- Mioblastoma de células granulosas
- Dermatofibrosis lenticular
- Acantoma de células claras
- Dermatofibrosarcoma protuberans

Manejo Clínico

Principalmente Observación. Escisión quirúrgica indicada solo por motivos estéticos severos o si causa sintomatología limitante (por ser una lesión benigna profunda, la escisión deja cicatriz).

ALERTA CRÍTICA: Melanoma Nodular / Melanoma Maligno.

Los DF muy pigmentados y de reciente crecimiento deben ser evaluados exhaustivamente para descartar melanoma nodular, el cual es altamente invasivo.



Matriz de Síntesis Diagnóstica

Característica	Queratosis Seborreica	Queratosis Actínica	Dermatofibroma
Origen/Capa	Epidermis madura	Epidermis (queratinocitos basales)	Dermis (fibroblastos)
Clave Clínica	Escama grasosa "pegada"	Costra áspera eritematosa	Pápula/Nódulo firme oscuro
Signo Patognomónico	Signo de Leser-Trélat (erupción)	Patrón en fresa (grado 2)	Signo del Hoyuelo (pellizco)
Sello Histológico	Quistes córneos (pseudoquistes)	Paraqueratosis + atipia basal	Tejido fibroso desordenado
Potencial Maligno	Benigno (alerta si eruptivo)	PREMALIGNO (Carcinoma in situ)	Benigno

